

い^{2,5)}。また、他の病原微生物との複合感染が多いことも特徴のひとつで、複合感染症例は同時感染細菌の臨床像を強く反映し、細菌性肺炎の臨床像と類似する³⁾。一方、他の非定型病原体よりも自然治癒する傾向が強く、マウスへの感染実験でも証明されている。ヒトでの自然治癒症例の存在は集団発生の際に明らかとされており、実地医療では診断されず見逃されているかもしれない（図 1）。

診断・検査

a 検査法の種類

検査法は、臨床検体中に存在する菌体、菌体構成成分を検出する病原体検出法（分離培養法、蛍光抗体法、酵素抗体法、遺伝子検出法）と血清抗体価測定法に大別される。

b 抗体価測定法の問題点

抗体検査には原則ペア血清を必要とするが、早期診断には IgM 抗体価の測定が有用である。本邦ではエルナスとヒタザイム法が使用可能である⁶⁾。

IgG 抗体のペア血清採取の間隔は少なくとも 4 週間以上、ときに 8 週間が必要となる。IgM 抗体は病初期に検出されることから、初感染例の診断には有用である。ただし、症状発現後 10 日以内では抗体が産生

されないことが多く、迅速診断としての有用性は乏しい。

治療と予後

治療に際し重要なことは、抗菌薬が細胞内に十分移行することである。β-ラクタム系薬は細胞内移行が極めて低く、その標的とする細胞壁ペプチドグリカンを経るクラミジア属は有さないため、抗クラミジア活性をまったく示さない。細胞内移行が良好かつ強いクラミジア増殖抑制を示す抗菌薬には、テトラサイクリン系、マクロライド系、ニューキノロン系およびケトライド系などがある⁵⁾。

文 献

- 1) Miyashita N, et al : Kluwer Academic/Plenum Publishers, p11-28, 2004
- 2) Miyashita N, et al : Chest **121** : 1776, 2002
- 3) Miyashita N, et al : Respiriology **17** : 1073, 2012
- 4) Miyashita N, et al : BMC Infect Dis **13** : 129, 2013
- 5) 日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン 2024 作成委員会（編）：成人肺炎診療ガイドライン 2024，メディカルレビュー社，2024
- 6) Miyashita N, et al : Vaccine Immunol **15** : 1128, 2008